要介護認定調査票・ペルソナ症例 03

要介護認定基本調査・主治医意見書・概況調査統合データファイル

1. 調査実施者および調査対象者の情報

調査対象者氏名	鈴木 ハツエ（すずき はつえ）	**年齢 / 性別**	88歳 / 女性
要介護度	要介護3	**調査実施者**	市町村職員（保健師）

2. 現在受けているサービスの状況（概況調査）

【在宅利用・介護給付】通所介護（デイサービス）週5日、短期入所生活介護（ショートステイ）月7日、福祉用具貸与（車椅子・歩行器・特殊寝台）

3. 置かれている環境等（家族・居住環境・傷病等）

【家族状況】長男夫婦（50代）と同居（3世代世帯）。日中は長男夫婦が共働きで不在。
【居住環境】和室中心の旧家で段差が多く、ポータブルトイレ等を活用。
【主な介護者】長男の妻（主介護者）。
【傷病・既往歴】アルツハイマー型認知症（中等度〜重度）、腰椎圧迫骨折後遺症。

4. 主治医意見書（医学的記載事項）

主傷病名	アルツハイマー型認知症（中等度〜重度）、腰椎圧迫骨折後遺症
傷病の経過・治療内容	認知機能の低下が進行し、近稔性記憶の障害、見当識障害（時間・場所）、および周辺症状（BPSD：夕方の不穏、徘徊、介護拒否、被害妄想）が顕著化している。
医学的管理の必要性	抗認知症薬（アセチルコリンエステラーゼ阻害薬）の処方。骨粗鬆症治療薬の投与。血圧および全身状態の定期観察。
身体障害に関する意見	腰椎圧迫骨折後遺症による円背と軽度膝屈曲位。起立・歩行時に不安定性があり、転倒・再骨折リスクが高い。
精神・認知機能の意見	重度の認知機能低下。意思疎通は単語中心となり、夕方の日暮れ症候群、自宅内徘徊、オムツ交換時の介護拒否、被害妄想（財布の紛失等）がみられる。
特別医療・ケアの必要性	排泄・入浴・移動の全介助が必要。BPSDに対する環境調整および服薬・体調管理の医学的見守りが必要。
介護に関する医学的意見	在宅で介護する長男の妻の負担が限界に達している。徘徊や夜間不穏に対するIT見守り機器の導入、ならびにデイサービス（週5日）およびショートステイの活用による徹底したレスパイトが必要。

5. 要介護認定基本調査（全74項目）

第1群：身体機能・起居動作（全13項目）

1. 麻痺（上肢）：なし (1)
2. 麻痺（下肢）：なし (1)
3. 関節拘縮（上肢）：なし (1)
4. 関節拘縮（下肢）：軽度あり（円背と変形による膝屈曲位） (2)
5. 寝返り：自立 (1)
6. 起き上がり：一部介助 (2)
7. 座位保持：自立 (1)
8. 立位保持：不安定（見守りが必要） (2)
9. 歩行：歩行器または杖、見守り歩行 (2)
10. 立ち上がり：一部介助 (2)
11. 片足立ち：不可能 (4)
12. 洗顔：一部介助（手順の誘導が必要） (2)
13. 爪切り：全介助 (4)

第2群：生活機能（全12項目）

1. 移乗：一部介助 (2)
2. 移動（屋内）：見守りおよび一部介助 (2)
3. 移動（屋外）：全介助（車椅子使用） (4)
4. 食事摂取：一部介助 (2)
5. 排泄（トイレ動作）：全介助（オムツ併用およびポータブルトイレ誘導） (4)
6. 排泄（排便コントロール）：一部介助 (2)
7. 衣服着脱（上衣）：全介助 (4)
8. 衣服着脱（ズボン等）：全介助 (4)
9. 入浴：全介助 (4)
10. 口腔清潔：全介助 (4)
11. 洗髪：全介助 (4)
12. 買い物：できない (4)

第3群：認知機能（全9項目）

1. 意思の伝達：困難 (3)
2. 麻痺等による意思伝達の困難さ：なし (1)
3. 短期記憶：ほぼ全くなし (4)
4. 日付の理解：わからない (4)
5. 場所の理解：自宅の認識が曖昧（「帰る」と発言） (3)
6. 自分の名前：かろうじてわかるがフルネームは言えない (2)
7. 生年月日：わからない (4)
8. 同行者の認識：長男はわかるが嫁や孫の区別が曖昧 (3)
9. 徘徊：あり（自宅内での目的のない歩き回り、玄関から出ようとする） (3)

第4群：精神・行動障害（全15項目）

1. 薬の過量服薬：なし (1)
2. 収集癖：あり（ティッシュ等を大量に溜め込む） (3)
3. 落ち着きのない行動：あり（夕方そわそわする） (3)
4. 失敗に対するこだわり：なし (1)
5. 外出先での迷子：あり（過去に保護された経緯あり） (4)
6. 介護への抵抗：あり（オムツ交換や入浴時に大声で拒絶） (3)
7. 羞恥心の喪失：あり (3)
8. 不潔行為：あり（便をいじる等の行為が時々ある） (2)
9. 異食：なし (1)
10. 幻覚・妄想：あり（「財布を盗られた」等の被害妄想が夕方に出現） (3)
11. 夜間不穏：あり（夜中に起きてタンスを開ける等） (3)
12. 大声を出す：あり (2)
13. 徘徊：あり (3)
14. 興奮状態：あり (3)
15. 暴力行為：軽度あり (2)

第5群：社会生活への適応（全6項目）

1. 薬の管理：できない (4)
2. 金銭管理：できない (4)
3. 簡単な調理：できない (4)
4. 電話の利用：できない (4)
5. 社会的交流：できない (4)
6. 日常の意思決定：できない (4)

6. 特記事項（総合所見・ケアマネジメント留意点）

中等度〜重度のアルツハイマー型認知症が進行しており、BPSD（夕方の黄昏症候群、徘徊、介護抵抗、被害妄想）が顕著。日中仕事で不在となる長男の妻が在宅介護の負担を一身に背負っており限界に近づいている。自宅からの飛び出しリスクが高く、見守りITソリューションやデイサービス・ショートステイの活用が不可欠。